

- [Home](#)
- [Fiche prepECN](#)
- [Ma Fiche](#)
- [Consensus](#)
- [Imagerie](#)
- [Discussion](#)

Item 198: Dyspnée aiguë et chronique

28 décembre, 2010

Objectifs CNCI

- Diagnostiquer une dyspnée aiguë et chronique
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

Recommandations

- Polycopiés nationaux

. CEP: [item 198](#)

. ORL: [item 198](#)

Mots-clés / Tiroirs

- Dyspnée aiguë <2S / chronique >1M
- FR < 12: bradypnée / > 20: polypnée
- Obstructive si bradypnée + s. de lutte
- RTx / GDS / iono-crét / ECG / NFS
- DO: exp/insp ; sib/crep ; strid/corn.
- DNO: cardio / pneumo / Hb / acidose

NPO / PMZ9

- Arrêt du tabac / substitution
- Recherche des s. de gravité
- ECG-troponine si FdR CV
- SpO2 normale si anémie

- Généralités

- Définitions
 - Dyspnée = perception *subjective* d'une gêne respiratoire par le patient
 - On distingue: dyspnée aiguë (< 2S) et dyspnée chronique (> 1M)
- Physiopathologie
 - Concept de dissociation neuro-mécanique: perception d'une inadéquation entre

- le degré d'activation des structures cérébrales de contrôle (TC ++)
- les réafférences en rapport avec les mouvements respiratoires effectués

- Orientation diagnostique

● Examen clinique

○ Interrogatoire

- Terrain: atcd respiratoires (asthme / BPCO) / cardiaques (ICG)
- Prises: médicaments (opiacés dont anti-tussifs) / toxiques: **tabac** +++
- Anamnèse: ancienneté / mode de survenue / facteur déclenchant
- Signes fonctionnels
 - Caractériser la dyspnée +++
 - Durée: aiguë (< 2S) ou chronique (> 4S)
 - Rythme: bradypnée (FR < 12/min) ou polypnée (FR > 20/min)
 - Temps: dyspnée inspiratoire / expiratoire / aux deux temps
 - Amplitude: dyspnée de Kussmaul / de Cheynes-Stokes
 - Circonstances: dyspnée d'effort / de repos / orthopnée
 - Rechercher des signes associés
 - Bruits respiratoires: cornage / stridor / wheezing

○ Examen physique

- Prise des constantes: FR-SpO2 / PA-FC / température
- Rechercher de signes de détresse respiratoire +++
 - signes de lutte: tirage / ailes du nez / épuisement (BTA / gasps)
 - signes d'hypoxémie: **cyanose** / extrémités pâles et froides
 - signes d'hypercapnie: sueurs / HTA / céphalées
 - DEP: systématique en cas de dyspnée obstructive (asthme ++)
- Evaluation du retentissement: signes de gravité (PMZ)
 - circulatoires: collapsus / signes de choc (marbrures)
 - neurologiques: troubles de la conscience: encéphalopathie
 - septiques: SRIS / sepsis sévère / choc septique
 - réponse: non amélioration sous O2 à fort débit +++
- Orientation étiologique clinique
 - Recherche de crépitations (en foyer = PAC / bilatéraux = OAP ou SDRA)
 - Recherche de signes d'insuffisance cardiaque: gauche et/ou droite
 - Recherche d'une phlébite des membres inférieurs / d'un pneumothorax, etc.
 - !! En pratique, distinguer +++
 - dyspnée obstructive: bradypnée avec signes de lutte
 - dyspnée non obstructive: polypnée sans signes de lutte

● Examens complémentaires

○ Examens systématiques devant toute dyspnée (5)

- Radiographie thorax face/profil: orientation étiologique
- Gaz du sang artériels +++ : retentissement de la dyspnée
- Iono-créatinine: recherche une acidose métabolique
- ECG de repos: recherche de signe de surcharge droite
- NFS: recherche une polyglobulie / une anémie

○ Examens selon orientation étiologique

- Echographie cardiaque: si suspicion ICG / EP massive / choc
- Marqueurs biologiques +++
 - BNP (ou NT-proBNP): dyspnée d'origine pulmonaire si BNP < 100 pg/mL

- Troponine: recherche un infarctus du myocarde / !! si FdR CV = PMZ
- D-Dimères: élimine une embolie pulmonaire si < 500ng/ml

- Diagnostic étiologique

- Dyspnée obstructive (= bradypnée avec signes de lutte)
 - Si expiratoire = obstacle bronchique
 - Avec sibilants isolés: asthme (si réversible) / BPCO (sinon)
 - Avec sibilants + crépitations: OAP sur IVG ++ / RM / PHS
 - Si inspiratoire = obstacle laryngé
 - Avec stridor (= sus-glottique): laryngomalacie / épiglottite / CE
 - Avec cornage (= sous-glottique): laryngite / hémangiome / CE
- Dyspnée non-obstructive (= polypnée sans signes de lutte)
 - Par défaut d'oxygénation ($TaO_2 = Q_c \times SaO_2 \times Hb$)
 - sur dysfonction cardiaque ($\downarrow Q_c$)
 - IVG +++ / insuffisance coronaire / péricardite / AC-FA
 - sur dysfonction pulmonaire ($\downarrow SaO_2$)
 - bronchique: BPCO chronique / DDB / atélectasie
 - parenchymateuse: OAP / pneumonie / tumeur / PID
 - vasculaire: embolie pulmonaire / HTAP
 - pleurale: pleurésie / pneumothorax
 - sur modification de Hb ($\downarrow Hb$)
 - toutes les étiologies d'anémie: cf [item297">PMZ](#))
 - [Par hyperventilation compensatrice \(Kussmaul\)](#)
 - [Sur acidose métabolique \(pour éliminer le CO₂\)](#)
 - [à TA augmenté: acido-cétose / acidose lactique / lyse](#)
 - [à TA normal: diarrhée \(perte de HCO₃⁻\) / rénal \(NTI\)](#)
 - [Par défaut de la commande nerveuse \(!! hypoventilation\)](#)
 - [Intoxication: morphiniques / barbituriques..](#)
 - [Neurologiques: myasthénie / Guillain-Barré / AVC](#)
 - [Autres causes](#)
 - [Déconditionnement physique](#)
 - [Dyspnée psychogène ++](#)

-

- [Stratégie diagnostique](#)

[A propos](#) - [Conditions Générales de Ventes](#) - [Informations Légales](#) - [F.A.Q](#) - [Nous contacter](#)

Copyright © 2011 prepECN, all rights reserved - Powered by [Allworldregister.info](#)

chargement